

Hyperplasie bénigne de la prostate

QCM 1

Concernant l'adénome prostatique

- A. Son poids peu varier de 20 à 300 g
- B. Anatomopathologiquement il s'agit d'un adénomyofibrome
- C. Il n'y a pas de parallélisme anatomo-clinique
- D. Il peut être trilobé
- E. Il est toujours symptomatique.

QCM 2

La dysurie est caractérisée par

- A. Une diminution de la force du jet urinaire
- B. Une miction retardée
- C. Une durée mictionnelle allongée
- D. Une miction fréquente en petite quantité
- E. Une envie irrésistible d'uriner

QCM 3

Concernant l'adénome prostatique, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s)

- A. Est une hyperplasie adénomyofibromateuse bénigne
- B. Elle développée à partir de la zone centrale de la prostate
- C. Après l'âge de 60 ans, 40% des hommes présenteront une HBP clinique
- D. 80 % des hommes ayant une HBP nécessitent une chirurgie
- E. Il peut se voir à partir de l'âge de 40 ans

QCM 4

Le score IPSS

- A. Confirme le diagnostic d'adénome prostatique
- B. Varie de 0 à 35
- C. Comprend 7 questions sur les symptômes du bas appareil urinaire
- D. Confirme le diagnostic d'adénome prostatique s'il est supérieur à 20
- E. Permet la mesure du volume prostatique

QCM 5

Une hyperplasie bénigne de la prostate se développe à partir

- A. De la zone de transition de la prostate uniquement
- B. Du stroma fibromusculaire antérieur de la prostate
- C. De la zone centrale de la prostate uniquement
- D. De la zone de transition et de la zone des glandes péri-urétrale
- E. De la zone périphérique de la prostate

QCM 6

Le traitement médical de l'hyperplasie bénigne de la prostate comporte

- A. Les alpha-bloquants
- B. Les alpha-stimulants
- C. Les bétabloquants
- D. La phytothérapie
- E. Les inhibiteurs de la 5 alpha réductase

QCM 7

La débimétrie

- A. Permet d'objectiver la dysurie
- B. Le volume uriné doit être supérieur à 250 ml pour qu'elle soit interprétable
- C. Une courbe normale présente une forme en cloche
- D. Permet d'étudier le débit maximal
- E. Un débit maximal < 15 ml/s signe une obstruction à l'écoulement des urines

QCM 8

Concernant l'hyperplasie bénigne de la prostate, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s)

- A. Le diagnostic est essentiellement clinique
- B. Est une pathologie de l'adulte jeune
- C. Le traitement d'une HBP compliquée est chirurgical
- D. Se développe exclusivement au niveau de la zone de transition de la prostate
- E. L'évolution naturelle se fait parfois vers la dégénérescence

QCM 9

Quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) concernant l'hyperplasie bénigne de la prostate

- A. Le traitement médical est indiqué en cas de gêne modérée à sévère
- B. Peut nécessiter une simple surveillance
- C. L'incision trigono cervico prostatique est indiquée chez le sujet jeune ayant une HBP de plus de 40 g
- D. La résection transurétrale de la prostate est indiquée pour un adénome de 90g
- E. Il est possible d'associer un α -bloquant et un inhibiteur de la 5 α -réductase

QCM 10

Quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) concernant le score IPSS

- A. Un malade est modérément symptomatique si le score IPSS est entre 8 et 19
- B. Est utile pour la surveillance post-thérapeutique
- C. Est un score objectif faisant partie du bilan initial d'un adénome de la prostate
- D. Il est utilisé dans la décision thérapeutique
- E. Il comprend 7 questions relatives à la symptomatologie présentée durant le mois passé

QCM 11

Parmi les examens suivants, quels sont ceux qui sont demandés de première intention pour un patient de 65 ans présentant une HBP

- A. Dosage de la créatininémie
- B. Bandelette urinaire ou ECBU
- C. Echographie rénale et vésicoprostatique
- D. Débimétrie
- E. Dosage PSA

QCM 12

Le traitement d'un patient présentant une hyperplasie bénigne de la prostate compliquée d'une insuffisance rénale consiste en :

- A. Un traitement chirurgical
- B. Un traitement par phytothérapie
- C. Une surveillance
- D. Un traitement par alpha-bloquants
- E. Traitement par inhibiteur de la 5 alpha-réductase

QCM 13

Un adénome de la prostate peut se compliquer de

- A. Lithiase vésicale
- B. Diverticules vésicaux
- C. Insuffisance rénale
- D. Ejaculation rétrograde
- E. Epididymite récidivante

QCM 14

Quelles sont parmi les propositions suivantes, celle(s) qui constitue(nt) une indication chirurgicale de l'hyperplasie bénigne de la prostate

- A. Distension urinaire avec insuffisance rénale
- B. Score d'IPSS à 30
- C. Lithiase vésicale
- D. Un taux de PSA >15ng/ml
- E. Prostate de poids > 120 gr

QCM 15

Quel (s) examen (s) feriez-vous pratiquer chez un homme de 76 ans consultant pour dysurie et qui présente à l'examen clinique une hyperplasie prostatique non suspecte ?

- A. Urographie intraveineuse
- B. Débitmétrie
- C. Urétrocystographie
- D. Dosage de PSA
- E. Mesure du résidu post-mictionnel

QCM 16

Un adénome prostatique peut se révéler par

- A. Orchiépididymite récidivante
- B. Dysurie
- C. Hématurie
- D. Rétention aiguë d'urine
- E. Fuites urinaires insensibles

QCM 17

Concernant le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate, cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s)

- A. Le type du traitement chirurgical dépend du score IPSS
- B. L'incision trigono-cervico-prostatique peut être discutée chez le sujet jeune ayant une HBP < 50 g
- C. La résection transurétrale de la prostate (RTUP) est indiquée pour les grosses prostates
- D. Le syndrome de résorption (d'hémodilution) est une complication de l'adénectomie Trans vésicale
- E. La sténose urétrale est une complication postopératoire possible

QCM 18

Selon le concept de Mac Neal, le (les) siège(s) de prédilection du développement d'une hypertrophie bénigne de la prostate est

- A. La zone périphérique
- B. La zone centrale
- C. La zone fibromusculaire
- D. La zone de transition
- E. La zone péri-urétrale

QCM 19

Au cours d'une hyperplasie bénigne de la prostate, le toucher rectal permet de trouver

- A. Une prostate augmentée de volume
- B. Une prostate lisse et régulière
- C. Une prostate douloureuse
- D. Une prostate dure
- E. Un effacement du sillon médian

QCM 20

Quel est le traitement adéquat d'une HBP de 30 grammes associée à une lithiase vésicale de 2 cm de diamètre chez un homme âgé de 60 ans en bon état général ?

- A. Un traitement médical à base de phytothérapie
- B. Un traitement médical à base d'alpha bloquant
- C. Une résection endoscopique de la prostate avec lithotritie endovésicale du calcul
- D. Une adénectomie par taille vésicale avec ablation du calcul de vessie
- E. Une abstention surveillance

QCM 21

Le traitement chirurgical d'une hyperplasie bénigne de la prostate a pour principal inconvénient sexuel

- A. Une impuissance définitive
- B. Une anéjaculation
- C. Une diminution de l'orgasme
- D. Une éjaculation rétrograde
- E. Une diminution du désir sexuel

QCM 22

Lorsque l'adénome prostatique devient obstructif et en l'absence d'un traitement approprié, schématiquement plusieurs phases peuvent se succéder sauf une laquelle

- A. Dysurie avec vessie de lutte
- B. Rétention vésicale incomplète
- C. Distension vésicale
- D. Distension du haut appareil
- E. Hématurie terminale

QCM 23

Parmi les propositions suivantes concernant l'adénome prostatique Laquelle est correcte ?

- A. L'HBP se développe au niveau de la prostate périphérique
- B. Un volume uriné supérieur à 100 ml associé à un débit urinaire inférieur à 15 ml/s représentent des signes d'obstruction
- C. Le traitement chirurgical de l'HBP enlève toute la glande prostatique et élimine ainsi le risque de survenu de cancer de la prostate
- D. Parmi les indications chirurgicales on retient la distension vésicale chronique
- E. L'HBP est un facteur de risque de cancer de la prostate

QCM 24

La cause la plus fréquente d'une rétention aigue d'urines chez un patient âgé de 65 ans est

- A. Cancer de la prostate
- B. Prostatite chronique
- C. Sténose urétérale
- D. Hypertrophie bénigne de la prostate
- E. Abscès prostatique

QCM 25

Parmi les modalités thérapeutiques suivantes quelle est la modalité de choix pour un adénome de prostate de 120g modérément symptomatique avec retentissement sur la qualité de vie ?

- A. Résection endoscopique
- B. Incision du col vésical
- C. Adénectomie transvésicale
- D. Traitement médical par les inhibiteurs de la 5 alpha réductase
- E. Traitement médical par les alpha-bloquants

QCM 26

Selon l'anatomie zonale de Mc NEAL

- A. La prostate est subdivisée en 5 zones
- B. La zone de transition représente 70 % du volume prostatique
- C. La zone de transition représente 5 % du volume prostatique
- D. La zone centrale au contact de l'urètre est le siège d'HBP dans 5 % des cas
- E. L'urètre prostatique traverse la zone de transition

QCM 27

Quel traitement de première intention proposez-vous pour un patient ayant une HBP symptomatique non compliquée avec un score IPSS à 35

- A. Abstention/surveillance + règles hygiéno-diététiques
- B. Une incision trigono-cervico-prostatique
- C. Un traitement médical par les alpha-bloquants
- D. Un traitement médical associant un α -bloquant et une 5 α -reductase
- E. Un traitement médical associant un α -bloquant et un anticholinergique

Cancer de la prostate

QCM 01

Quel(s) examen(s) est (sont) réalisé(s) de première intention dans le dépistage d'un cancer de la prostate ?

- A. Toucher rectal
- B. Dosage du PSA
- C. Dosage de la phosphatase acide
- D. Echographie endorectale
- E. Dosage du PCA 3

QCM 02

Le cancer de la prostate a comme facteur de risque

- A. La race noire
- B. L'âge
- C. Les antécédents familiaux de cancer de la prostate
- D. La vasectomie
- E. L'hyperplasie bénigne de la prostate

QCM 03

Quelles sont les caractéristiques du TR en cas de cancer de la prostate

- A. Nodule dur
- B. Nodule indolore
- C. Blindage pelvien
- D. Anormal si PSA élevé
- E. Consistance élastique de la prostate

QCM 04

Le dosage du taux de PSA sanguin dans le cadre du cancer de la prostate :

- A. Doit être pratiqué après l'âge de 60 ans
- B. N'a pas intérêt dans le bilan d'extension du cancer de la prostate
- C. Permet la surveillance post thérapeutique
- D. Est considéré comme un facteur pronostic pré et post thérapeutique
- E. Le dosage de la fraction libre est utile en première intention

QCM 05

Les biopsies prostatiques sont réalisées : (une ou plusieurs réponses sont justes)

- A. Sous guidage digital
- B. Sous antibioprophylaxie
- C. Sous guidage échographique
- D. Après vérification de la stérilité des urines
- E. En visant uniquement un éventuel nodule prostatique

QCM 06

Concernant le dépistage du cancer de la prostate : quelles sont les réponses exactes ?

- A. Il permet un diagnostic précoce du cancer prostatique
- B. Il est recommandé entre 50 et 70 ans
- C. Il repose sur le toucher rectal ou le dosage PSA
- D. Il commence à l'âge de 45 ans chez les hommes à risques
- E. L'intervalle entre deux tests de dépistage est habituellement de 6 mois pour les jeunes adultes

QCM 07

Concernant le dépistage du cancer de la prostate

- A. Il s'agit d'un dépistage de masse
- B. Il s'agit d'un dépistage obligatoire
- C. Repose sur le toucher rectal et le dosage du PSA sérique
- D. Il est recommandé chez les hommes de 50 à 70 ans
- E. L'espérance de vie est un critère à prendre en considération

QCM 08

Concernant l'antigène spécifique de la prostate

- A. Il est spécifique du cancer de la prostate
- B. Il a un intérêt pour le diagnostic et la classification
- C. Il a un intérêt pour le pronostic
- D. Il a un intérêt pour la surveillance
- E. Son taux normal doit être supérieur à 4 ng/ml

QCM 09

Parmi les facteurs qui augmentent le taux de PSA

- A. Cancer de la prostate
- B. Adénome de la prostate
- C. Prostatite
- D. Le toucher rectal
- E. Le massage prostatique

QCM 10

Le score de Gleason dans le cancer de la prostate :

- A. Repose sur l'étude de la différenciation du tissu tumoral
- B. Est basé sur l'architecture glandulaire
- C. Additionne les grades des 2 contingents tumoraux les plus représentés
- D. Représente un facteur pronostic important de cancer prostatique
- E. Les cancers de score 8 à 10 sont bien différenciés et de mauvais pronostic

QCM 11

Le cancer de la prostate (indiquez la (les) bonne(s) réponse(s))

- A. Se développe exclusivement au niveau de la zone périphérique de la prostate
- B. Peut se développer au dépend de la zone fibromusculaire antérieure
- C. Se développe dans 75% des cas au niveau de la zone périphérique de la prostate
- D. Se développe dans 5% des cas au niveau de la zone centrale de la prostate
- E. Se développe dans 15% des cas au niveau de la zone transitionnelle de la prostate

QCM 12

En présence d'une prostate dure et nodulaire au toucher rectal chez un patient de 60 ans, le premier diagnostic à évoquer est

- A. Cancer de la prostate
- B. Hypertrophie bénigne de la prostate
- C. Lithiase prostatique
- D. Prostatite chronique
- E. Tuberculose prostatique

QCM 13

Concernant le cancer de la prostate

- A. Les cancers de la zone transitionnelle sont plus faciles à diagnostiquer que ceux de la zone périphérique
- B. Le bilan d'extension comprend systématiquement une TDM TAP pour l'extension métastatique
- C. Le dosage du taux de PSA devient facultatif si le TR est normal
- D. La TDM est le meilleur examen pour l'appréciation de l'extension locorégionale
- E. Le taux de PSA post thérapeutique est un facteur pronostic

QCM 14

Concernant le bilan d'extension du cancer de la prostate

- A. Comprend systématiquement une scintigraphie osseuse
- B. L'IRM prostatique est réalisée avant de réaliser les biopsies prostatiques
- C. Le TR surestime le stade clinique
- D. L'échographie endorectale est très fiable pour l'étude de l'envahissement de la capsule
- E. Le curage ganglionnaire est le meilleur moyen pour affirmer le diagnostic de métastases ganglionnaires

QCM 15

Le traitement curatif du cancer de la prostate peut comprendre :

- A. Prostatectomie radicale
- B. Radiothérapie conformationnelle
- C. Curiethérapie prostatique
- D. Castration chirurgicale
- E. Traitement par les agonistes de la LH RH

QCM 16

Le traitement palliatif du cancer de la prostate métastatique peut comprendre :

- A. Prostatectomie radicale
- B. Castration chirurgicale
- C. Hormonothérapie par les agonistes ou les antagonistes de la LH RH
- D. Radiothérapie à visée antalgique sur les sites métastatiques
- E. Une curiethérapie

QCM 17

Le traitement d'un cancer prostatique localisé à la glande prostatique chez un patient ayant une EDV de plus de 10 ans (indiquez la (les) bonne(s) réponse(s))

- A. Une adénomectomie transvésicale
- B. Une prostatectomie radicale
- C. Un traitement par les inhibiteurs de la 5 alpha réductase
- D. Une pulpectomie bilatérale
- E. Un traitement par les anti-androgènes

QCM 18

Devant un cancer de la prostate classé T2b N0 M1a, le traitement peut comporter

- A. Une prostatectomie radicale seule
- B. Des analogues de la LH-RH
- C. Une prostatectomie radicale suivie d'une hormonothérapie
- D. Une association hormonothérapie - radiothérapie
- E. Une pulpectomie bilatérale

QCM 19

Quel est le traitement le mieux adapté pour un cancer prostatique avec métastases osseuses symptomatiques chez un patient de 80 ans multi-tarés

- A. Une Abstention surveillance
- B. Une radio-hormonothérapie
- C. Une prostatectomie radicale
- D. Une castration chirurgicale ou médicamenteuse
- E. Une résection endoscopique de la prostate périphérique

QCM 20

Concernant la surveillance post-thérapeutique d'un cancer de la prostate : quelles sont les réponses exactes ?

- A. Comprend un examen clinique systématique
- B. Comprend systématiquement un dosage du PSA total
- C. Comprend le dosage de la testostéronémie
- D. Comprend une TDM abdomino-pelvienne
- E. Comprend une biopsie annuelle en cas de traitement par radiothérapie (prostate laissée en place)

QCM 21

Concernant le cancer de la prostate : quelles sont les réponses exactes ?

- A. Le type histologique le plus fréquent est l'adénocarcinome ductal
- B. Est un cancer lymphophile
- C. Les métastases osseuses sont typiquement ostéolytiques et intéressent quasi exclusivement le squelette axial
- D. Le rhabdomyosarcome est le sarcome le plus fréquent de l'adulte
- E. L'envahissement rectal est fréquent en cas de cancer de la zone périphérique

QCM 22

Concernant la surveillance active dans le traitement du cancer de la prostate :

- A. Est indiquée pour les cancers à haut risque
- B. Son indication est indépendante du score de Gleason
- C. Tiens compte du taux de PSA sanguin
- D. Est une modalité thérapeutique palliative
- E. Elle comprend un examen clinique, un dosage de PSA, une IRM prostatique et des biopsies prostatique de contrôle

Cas clinique

Patient de 68 ans, consulte pour troubles urinaires du bas appareil urinaire. Pas d'antécédents pathologiques particuliers.

A l'examen clinique: prostate indurée, nodule du lobe gauche de 5mm respectant parfaitement les contours de la glande.

A la biologie : taux de PSA à 10,2 ng/ml

Question 1

Quel examen permet de confirmer le diagnostic d'adénocarcinome prostatique de la prostate ?

- A. Examen cytologique des sécrétions recueillis après massage prostatique
- B. Dosage des phosphatases acides
- C. Dosage du PSA
- D. Examen cytologique des urines après massage prostatique
- E. Biopsie prostatique

Cas clinique

L'examen anatomopathologique de la biopsie prostatique a conclu à un adénocarcinome prostatique score 7 (3+4) de Gleason du lobe gauche

